<2022 본 3 학년말고사- 산부인과>

총 60 문제 중 60 문제 복원

학년말고사 기출 문제, 당해 내신 야마가 골고루 꽤 나왔고 일부 변형도 있습니다.

부인과

[임신에 대한 모체의 적응]

1. 모체 생리의 변화에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

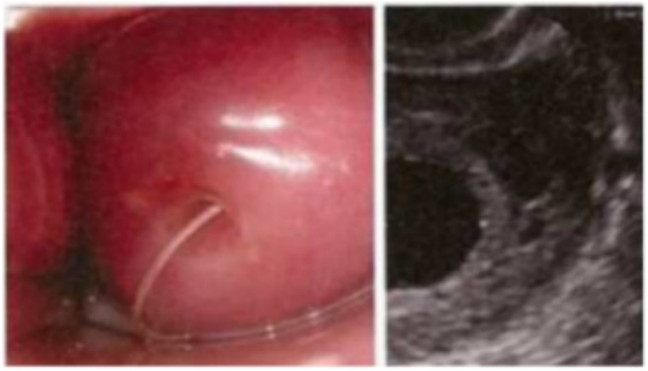
   - hCG 의 역할은 황체 유지이다.
   - 제왕자궁절제술 시 혈액의 소실이 1.5L 이상 가능하다.
   - 임신 중 산모의 총 혈액량은 임신 제 32 주에 최대치를 보이며 이후 감소한다.
   - 임신 말기 산모의 Hb 농도는 11.0g/dl 이하는 비정상으로 간주한다.
   - 임신 제 3 분기에 필요한 일일 철요구량은 7mg/dl 이상이다.

2. 모체 생리의 변화에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

   - 산모에게 Angiotensin II 주입 시 혈압이 증가한다.
   - 임신 전 유방의 크기와 모유 생성량은 관계가 없다.
   - 임신 시 질의 산도 pH 3.5~6 으로 유지된다.
   - 임신 시 Th1 세포와 NK cell 이 억제된다.
   - 임신 시 태아에게 원활하게 glucose 를 공급하기 위해 diabetogenic 한 상태가 된다.

[가족계획]

3. 39 세 산과력 0-0-3-0 여성이 무월경으로 내원하여 hCG 검사를 시행한 결과 양성이었다. 1 년 전 자궁내장치 시술을 받았다. 질경검사 사진과 초음파 검사 사진이다. 처치는?



   - 프로게스테론 투여
   - 경과관찰
   - 입원 후 융모막 융모 생검
   - 항생제 투여
   - IUD 제거

[불임]

4. 다음은 과배란 유도 후 생길 수 있는 난소과자극증후군(OHSS)의 특징에 대한 설명이다. 틀린 것은?

   - 난자 채취 후 9 일 이내에 생기는 경우를 초기 OHSS 으로 정의하며 혈중 estradiol 이 높은 경우와 난자 개수가 관련이 있다.
   - 중증 OHSS 는 약 1%에서 나타나며, 호흡곤란, 복부팽만 등 생명을 위협할 수도 있다.
   - OHSS 를 예방하는 방법으로 gonadotropin 투여를 중지하고, 3-5 일까지 hCG 를 늦추는 costing 방법을 사용하면 도움이 된다.

- OHSS 를 예방하는 방법으로 최종 난자 성숙을 위하여 낮은 용량의 hCG(5000IU)나, recombinant LH 또는 GnRH antagonist 를 투여하는 것도 도움이 된다.
- 체외수정시술을 위한 과배란 유도로 난소 과자극 증후군이 생긴 경우 해당 주기를 취소하고 모든 배아를 냉동 보관하는 방법도 있다.

5. 체외수정과 배아이식을 위해 과배란 유도에 대한 설명으로 틀린 것은?
   - hCG 는 난자 성숙을 위해 난자 채취 전 34~36 시간에 투여한다
   - GnRH agonist 는 long protocol 이 short protocol 에 비해 임신률이 높다.
   - GnRH agonist 는 flare up secretion 없이 FSH, LH 분비를 억제할 수 있다는 장점이 있다.
   - GnRH antagonist fixed protocol 은 생식샘자극호르몬 투여 4~7 일 후에 투여한다
   - GnRH antagonist flexible protocol 은 난포 12-16mm 일 때 투여하면 황체호르몬 분비 폭발을 막을 수 있다.

[부인과 감염질환]

6. 24 세 산과력 0-0-2-0 인 여자가 7 일 전 성관계 이후 발생한 질분비물 증가로 병원에 왔다. 배뇨통, 빈뇨, 절박뇨가 동반되었다. 골반검사에서 요도에 고름이 보이고, 자궁목에도 심한 미란과 함께 고름이 보인다. PCR 을 이용한 성매개 감염검사 결과는 다음과 같다. 적절한 처치는?

클라미디아트라코마티스(Chlamydia trachomatis) – 양성
미코플라스마제니탈리움(Mycoplasma genitalium) – 음성
미코플라스마호미니스(Mycoplasma hominis) – 음성
임균(Neisseria gonorrheae) -양성
질편모충(Trichomonas vaginalis) – 음성

   - 세프트리악손 + 아지트로마이신
   - 세파졸린 + 겐타마이신
   - 암피실린 + 플루코나졸
   - 아시클로버 + 메트로니다졸
   - 에리트로마이신 + 메트로니다졸

[자궁경부암]

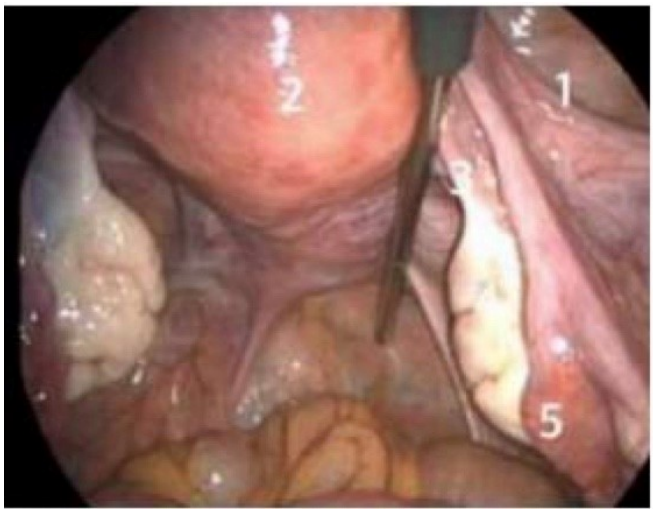
7. (22 총괄) 다음은 FIGO stage 1B 로 확인된 자궁경부암 환자의 수술 사진이다. 화살표로 표시한 구조물은?



   - Left ureter
   - Left obturator nerve
   - Left uterine artery
   - Left external iliac vein
   - Left external iliac artery

8. (22 계통)다음 사진에서 나온 번호 순서대로 구조물을 나열하면?

(21 야마처럼, 5 번은 확실히 infundibulopelvic ligament 인 곳에 써있었음.)



- Cardinal ligament-Uterus-Right ovarian ligament-Right ovary-Right infundibulopelvic ligament
- Cardinal ligament-Uterus-Right ovarian ligament-Right salpinx-Right infundibulopelvic ligament
- Round ligament-Uterus-Left ovarian ligament-Left ovary-Left infundibulopelvic ligament
- Round ligament-Uterus-Right ovarian ligament-Right salpinx-Right infundibulopelvic ligament
- Round ligament-Uterus-Right ovarian ligament-Right ovary-Right infundibulopelvic ligament

9. (22 총괄) 산과력이 2-0-3-2 인 45 세 여자가 질 출혈을 주소로 내원하였다. 이전에 HSIL 로 판명되어 conization 을 시행했다. Colposcopy 결과 깊이 2mm, 넓이 6mm 인 자궁경부 침윤성 편평세포암종이 발견되었다. 환자가 더이상 임신할 계획이 없다고 할 때 적절한 치료는?



- 전자궁적출술 ('단순' 적혀있지 않았음)
- 정기적 추적관찰
- 근치적 자궁절제술, 골반 림프절 절제술
- 변형된 근치적 자궁절제술, 골반 림프절 절제술
- 전골반내용적출술

10. (22 총괄) 산과력 3-0-4-3 인 55 세 여성이 성교 후 질 출혈을 주소로 내원하였다. 개인 의원에서 실시한 자궁경부 세포 검사 결과 HSIL 이었다. 자궁경부에 2~3cm 크기의 종괴가 관찰되었고, 침윤성 편평세포암종이었다. 다음으로 시행할 적절한 조치는?

- 근치적 자궁절제술, 골반 림프절 절제술
- 변형된 근치적 자궁절제술, 골반 림프절 절제술
- 단순 전자궁적출술
- 이미 conization 을 실시하였으므로 경과를 관찰한다.
- 다시 conization 을 한다.

11. (22 총괄) 산과력 2-0-1-2 인 60 세 여성이 질 출혈을 주소로 내원하였다. 개인 의원에서 실시한 자궁경부 세포 검사 결과 HSIL 이었다. 자궁경부에 3~4cm 크기의 종괴가 관찰되었고, 침윤성 편평세포암종이었다. 진찰 및 MRI 소견이다. 다음으로 시

행할 적절한 조치는? (*MRI 에서 자궁경부에만 종괴가 관찰되었음, 주변 침윤 X.)



- 근치적 자궁절제술, 양측 난소난관절제술, 골반 림프절 절제술
- 변형된 근치적 자궁절제술, 양측 난소난관절제술, 골반 림프절 절제술
- 정기적 추적관찰
- 단순 전자궁적출술
- 동시항암화학방사선치료

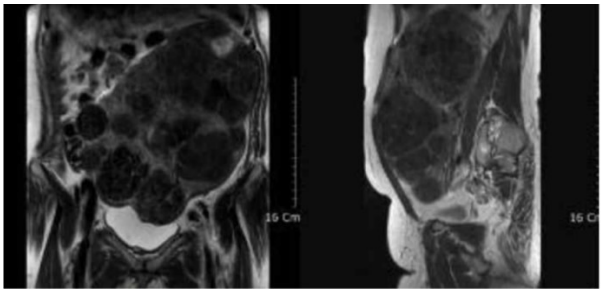
12. (22 총괄) 산과력이 2-0-1-2 인 60 세 여성이 자궁경부암으로 치료를 받았다. 근치적 자궁 절제술 및 배막뒤림프절절제술을 시행했는데, 수술 소견은 다음과 같다. 골반강 근처 림프절은 전이되었지만 대동맥 근처 림프절은 전이되지 않았다. 환자의 병기와 다음으로 해야 할 처치는?



- IIC, 면역요법
- IIIC1, 항암화학요법
- IIIC2, 항암화학요법
- IIIC1, 동시항암화학방사선치료
- IIIC2, 동시항암화학방사선치료

[자궁근종]

13. (22 형성) 32 세 산과력 0-0-1-0 여자가 어지럼증으로 왔다. 환자는 평소에 류마티스 관절염으로 10 년전부터 치료약을 복용 중이다. 평소에 월경은 규칙적으로 하였지만 월경 때마다 덩어리가 나오고 2 시간마다 대형패드를 교체하였다. 신체 진찰 결과 복부는 임신 6 개월 크기로 불러 있었고 단단하고 움직이지 않는 종괴가 만져졌다. 검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게서 선택할 수 있는 치료 옵션 중 적절하지 않은 것은?



일반혈액검사
백혈구: 10,500/mm3 (4,000-10,000)
혈색소: 5.5g/dL (12-16)
적혈구용적률: 27% (36-48%)
혈소판: 145,000/mm3 (150,000-450,000)
크레아티닌: 0.94mg/dL (0.51-0.95)

- 개복을 통한 자궁 근종 절제술

- 프로제스테론을 이용한 호르몬 치료
- 고강도초음파집속술(HIFU)
- 복강경 수술을 통한 근종 절제술
- 수술 전 빈혈 교정을 위한 GnRH agonist 주입

[자궁상피내종양]

14. {22 형성) 42 세 산과력 2-0-0-2 여자가 월경간 이상 출혈로 왔다. 평소에 월경은 규칙적으로 하였다. 골반 내진 결과 비정상적으로 촉지되는 종괴는 없었다. 환자는 3 년전에 자궁경부암 예방 주사를 3 차례 모두 맞고 이후에 자궁경부암 선별검사를 시행하지 않았다고 한다. 검사결과는 다음과 같다. 치료는?



자궁경부암 선별검사: 비정형샘세포(Atypical glandular cell) 자궁경부 조직 검사: 상피내 선암종(Adenocarcinoma in situ) 인유두종바이러스: 33 번 양성

- 냉동요법(Cryotherapy)
- 완전자궁적출술(Total hysterectomy)
- 원추절제술(Conization with cold knife)
- 환상투열요법(Loop electrosurgical excision procedure; LEEP)
- 액상세포진, 인유두종바이러스, 콜포스코피 검사를 6 개월 간격으로 재검사

[자궁내막암]

15. (탈) 34 세 산과력 0-0-0-0 인 환자, 월경 간 질 출혈 반복되어 내원하였다. 자궁내막 두께는 19mm 였다. 치료는?

조직형: 자궁내막양 샘암 MRI: 자궁내막에 1.0 x 1.0 cm 의 high signal intensity 를 보이는 병변이 있었으며, 자궁근육층으로의 침범은 관찰되지 않음. CT: Abdominal lymph node 에 비대 없음. 다른 장기로의 전이 확인되지 않음. PET-CT: 자궁내막에 high metabolic activity 보이는 병변 있었으며 다른 곳에서는 이상 없음.

- 복강경 단순자궁적출
- 복강경 단순자궁적출 + 양측 난소난관절제 + 골반및대동맥림프절박리
- 경과관찰
- 일차 방사선치료
- 프로게스테론을 이용한 호르몬 치료

[난소암]

16. 20 세 대학생이 3 시간 전부터 시작된 극심한 좌하복부 통증으로 응급실 방분하였다. 활력징후 110/70-75-24-36.9 였고, 마지막 생리일은 2 주 전이었고, 성경험은 있었다. 응급실에서 시행한 CT 소견이 다음과 같다면, 올바른 진단은?



- 난소 기형종
- Endometrial sinus
- Endometrial hyperplasia

17. 2 년 전 위암 진단을 받은 48 세 여자 환자. CT 촬영 결과 양측 난소에 8cm, 10cm 난소 종괴가 관찰된다. 이 환자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 병리조직검사 시 Schiller-Duval body 가 관찰된다
- 대개 양측성이다
- 위, 장, 충수에서 주로 전이된다
- 예후가 나빠서 1 년 내에 사망한다
- 수술로 예후를 개선시키지는 못하나 증상 완화를 위해 수술한다

18. 17 세 여학생이 복부통증이 있어 응급실로 봤다. 수술 소견에서 혈복강이 심하였고, 종양 표지자 검사가 다음과 같을 때, 환자에게 적절한 치료가 아닌 것은?

CA 125	216.6 IU/ml
CA 19-9	11.7 IU/ml
AFP	14472 ng/Ml
β-hCG	⟨0.1 mIU/ml

- Unilateral oopherectomy
- 반대쪽 난소가 정상이면 biopsy 하지 않는다
- Stage IA 이기 때문에 항암요법을 시행하지 않는다.
- 방사선 치료는 하지 않않는다.
- 조직검사상 Schiller-Duval body 가 보인다.

19. 62/F. 난소암 Debulking surgery 하고 결과. 병기는?

Bilateral ovary and salpinx. Salpingooophorectomy. Serous adenocarcinoma. Moderately differentiated. with tumor size: Rt. (2.5 x 2.3 x 2.0 cm) Lt. (1.7 x 1.7 x 1.5 cm)

involvement of bilateral ovarian capsule, with penetration

Washing cytology: malignant cell (+)

Pelvic and para-aortic lymphadenectomy
Pelvic LN metastasis: (1/21), 7mm
Para-aortic LN metastasis: 2/26, 11mm, 9mm

Omentum and Omentectum: Malignant cell metastasis (+), 1cm

- IIIA1(i)
- IIIA2 (ii)
- IIIB
- IC1
- IIIC

[임신융모질환]

20. 60. 27 세 여자가 질출혈과 객혈을 주소로 내원하였다. 내진에서 자궁은 거위알 크기였고, 흉부 X 선 검사에서 왼쪽 폐에 동전 크기의 혹이 관찰되었다.

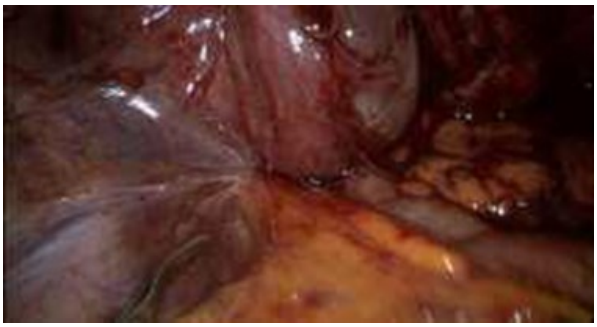
혈청 B-hCG 값은 150000 IU/L 이었다. 이 환자에게 시행해야 할 조치는?

- D&C
- 단독 항암화학요법
- 복합 항암화학요법
- 자궁절제술
- 방사선 치료

[자궁 내막증]

21. 29 세 미혼 여성, 성교통 및 질출혈로 내원하였다. 초음파 상에서 간유리음영의 낭종 확인되었고, 복강경 수술하였다. 우측 난소낭종제거술 후의 내시경 사진이며, 곧창자질사이막의 유착이 관찰되었다. 진단명은 무엇인가?





- 자궁내막종 및 곧창자질사이막 자궁내막증
- 자궁내막암
- 자궁근종
- 자궁샘근증

[무월경]

22. 16 세 여자 초경 없어 내원 염색체 검사 상 45, XO 옳지않은 것은?

- 드물게 y 염색체 있는 경우 streak gonad 제거하여 gonadoblastoma 예방
- 치료로 키 성장을 위해 2-8 세 GH 투여하여 4-16cm 성장이 목표
- 유방 발육을 촉진하기 위해 12-13 세에 에스트로젠 투여
- 에스트로젠은 처음엔 0.625-1.3mg 투여하다가 0.3-0.625mg 으로 감량 해 유지
- 자궁이 있으므로 프로게스테론을 게속 투여해야함

23. 다음 질환 중 자궁이 있을 가능성이 가장 적은 것은?

- Sheehan's syndrome
- 5-alpha reductase deficiency
- Pure gonadal dysgenesis
- Turner syndrome
- Kallmann's syndrome

24. Androgen insensitivy syndrome (complete form)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

- 사춘기 이전에 고환을 제거해야 한다.
- 자궁이 없다.
- 외성기가 모호하다.
- 염색체가 46 XX 이다.

[비정상 출혈]

25. Hb 5.5, 질출혈 많이 있었다. 내원 당시에는 질출혈 다소, 해야 할 처치로 옳지 않은 것은?

- 경구피임약을 7 일 간 하루 34 회 치료 후 용량을 줄여서 21 일 사용한다
- 약물 치료가 되지 않으면 소파술을 한다
- CEE 4 시간마다 25mg 투여
- 수액 보충을 하면서 입원 치료를 한다
- 우선 MPA 20mg 를 2 번 정도 투여한다

26. 20 세 여성 3 주간 지속되는 자궁 출혈 평소 생리주기 45-60 일 불규칙적 현재는 출혈 없음 혈색소 11.0 처치로 옳지 않는 것?

- 임신을 원하지 않을 경우 고용량 경구피임제 하루 3 회, 3 일간 투여
- 고용량 경구피임제 투여하다가 저용량 경구피임제로 변경해서 투여
- 경구피임약 금기인 경우 MPA 10mg 투여
- 14 일간 MPA 투여 후 14 일간 휴약하다가 다음 주기에 맞춰서 MPA 투약

[폐경]

27. 산과력 2-0-1-2 52 세 여자가 안면홍조, 발한, 불면증을 주소로 내원하였다. 3 년 전 우측 유방암을 진단받고 유방암 절제술을 하였다. 51 세 폐경을 하였으며 DEXA 결과 T score –3.0 이었다. 사용하지 않는 것이 좋은 치료는?(답논란)

- 선택적 세로토닌 흡수 억제제 투여
- 에스트로젠 단독 투여
- 칼시토닌 투여
- 비스포스포네이트 투여
- 낮은 에스트로젠과 프로게스테론 투여

* 22 계통 야마 답은 SSRI 로 표시되어 있으나 SSRI 는 vasomotor symptom 에 사용 가능. 환자는 유방암 병력이 있고 자궁이 존재하므로 에스트로젠 단독 투여를 하면 안된다는 의견 있었음.

[사춘기]

28. 성조숙증(사춘기 조발증, precocious puberty)에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- 8 세 이전에 이차 성징이 나타나는 것으로 여아에서 남아보다 흔하며 유방발달, 음모 출현, 질 출혈 등이 나타난다.
  - 기질적인 뇌 병변을 감별해야 하므로 Brain MRI 등 진단 영상학적 검사를 일차 검사로 해야 한다.
  - 최종 키 손실의 최소화가 중요하므로 키의 정상적인 성장을 유도하고 이차 성징의 발현 억제하는 것이 중요하다.
  - 사춘기 조발증의 1 차적 치료제는 GnRH agonist 로 bone age 13 세 이하일 때 사용하면 효과적이다.
  - 치료 시 혈중 E2 < 10pg/ml 로 유지하면서, Epiphysis 가 fusion 되고나 bone/chronologic age 가 일치할 때까지 치료를 한다.

[요실금]

29. 50 세 여성이 소변이 가끔 샌다고 내원하였다. 6 개월 전부터 소변을 참기 힘들었으며, 밤에 소변을 보기 위해 2 번 정도 일어났다. 기침을 하거나 운동을 할 때 소변이 새는 일은 없었다. Q-tip test 는 15 도였고, 요역동학 검사에서 방광의 불수의적인 수축이 있으면서 소변누출이 관찰되었다. 적절한 치료는?

- 질식자궁절제술

- 항콜린제
- 전방질봉합술
- 케겔운동
- 무긴장성 테이프

[수술전후처치]

30. 산부인과에서 진행하는 수술 중 예방적 항생제를 사용해야 하는 경우는 언제인가?

- 원추절제술
- 자궁내막용종 절제술
- 복강경 난소 절제술
- 질 후벽 봉합
- 무긴장성 테이프수술

산과

[산전 관리]

[산전 진단]

31. 태아 DNA 선별검사 결과의 해석에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 태아 DNA 선별검사 결과 저위험군으로 판정되고 초음파 검사상 주요 구조적 이상 소견(major anomaly)이 동반된 경우, 반드시 침습적 검사를 권 고한다.
나. 태아 DNA 선별검사 결과 저위험군으로 판정되고 초음파 검사상 단독 부수 소견(soft sign)이 있는 경 우, 침습적 검사를 권고하지 않는다.
다. 태아 DNA 선별검사에서 고위험군으로 판정되면 반드시 침습적 검사를 권고한다.
라. No call 그룹에서도 2.7%의 염색체 이상이 보고되고 있기 때문에 이 경우 재검보다는 정밀 초음파 검사및 침습적 검사를 권유한다.

- 가나다라
- 가나다
- 가다
- 나라
- 라

32. 모체 혈청 알파태아단백에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 태아 혈청과 양수에서 임신 13 주까지 증가하다가 이후 급격히 감소한다.
나. 모체 혈청 AFP 수치에 영향을 주는 인자에는 임신 주수, 산모 체중, 다태임신, 당뇨 등이 있다.
다. 다운증후군에서 AFP, uE3 은 감소하고, hCG 와 inhibin A 는 증가한다.
라. 모체 혈청에서는 임신 12 주 이후 주수에 따라 계속 증가하다가 26~28 주에 최고 농도가 된다.

- 가나다라
- 가나다
- 가다
- 나라
- 라

33. 산전진단검사에 관한 설명이다. 옳은 것은?

가. 목덜미 투명대가 3.0mm 이상시 태아 기형의 고위험군을 의미하므로 정밀 초음파검사와 태아염색체검사 가 필요하다.
나. 제 1 삼분기에 시행하는 병합선별검사는 11~14 주에 목덜미 투명대검사와 PAPP-A,

hCG 를 함께 측정하 는 것으로 다운증후군 진단율이 79~87%(양성 예측도 5%)이다.

다. 제 2 삼분기에 시행하는 모체혈청선별검사인 Quad test 는 16~18 주에 시행하며 AFP, hCG, uE3, inhibin A 를 측정한다.

라. 분할식 순차적 검사는 임신 제 1 삼분기 선별검사 시행 후, 결과가 저위험군이면 추가검사를 하지 않고, 중간 위험군이면 제 2 삼분기 선별검사 또는 NIPT 검사를 시행하고, 고위험군이면 침습적 진단검사를 시행한다.

- 가,나,다,라
- 가,나,다
- 가,다
- 나,라
- 라

34. (22 계통) 태아 DNA 선별검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 35 세 미만 저위험군 임신부에게 가장 적절한 검사는 '태아 DNA 선별검사'가 아니라 '모체혈청 선별검사' 이다.

나. 모체 혈액 내 태아 DNA 는 임신 4 주부터 검출되는 200 base pair 이하의 작은 조각이며 분만 후 2 시간 이내에 모체의 혈액으로부터 사라진다.

다. 태아 DNA 선별검사는 임신 10 주부터 시행할 수 있다.

라. 21, 18, 13 번 상염색체 수적 이상, 성염색체 수적이상, 그리고 미세 결실의 선별 검사에 활용할 수 있으며, 특히 다운증후군의 경우에는 검출률이 99%로 높다.

- 가나다라
- 가나다
- 가다
- 나라
- 라

[임신 중 태아감시]

35. 26 세 임신 37 주의 임산부가 병원에 내원하였다. BPP 가 8 점이었고, single vertical pocket 의 크기가 2cm 였다. 해야할 조치는?

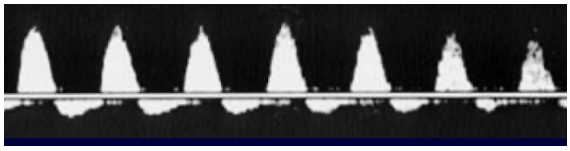
- 1 주 뒤 생물리학계수 측정
- 1 주 뒤 비수축 검사, 양수량 측정
- 응급제왕절개
- 분만
- 경과관찰

[초음파]

36. 임신 33 주, 산과력 0-0-0-0 인 산모의 태아 doppler 검사에서 Reversed end diastolic flow 가 관찰되었다. 처치는? (그림 주어지지 않고 문제 그대로 'Reversed end diastolic flow' 제시됨)

- 1 주 뒤 생물리학계수 측정
- 1 주 뒤 재검사
- 제왕절개
- 유도분만
- 경과관찰

37. 임신 35 주, 산과력 1-0-0-1 인 산모가 태동 감소를 주소로 내원하였다. 태아 doppler 검사에서 다음과 같은 결과가 나왔다. 처치는?

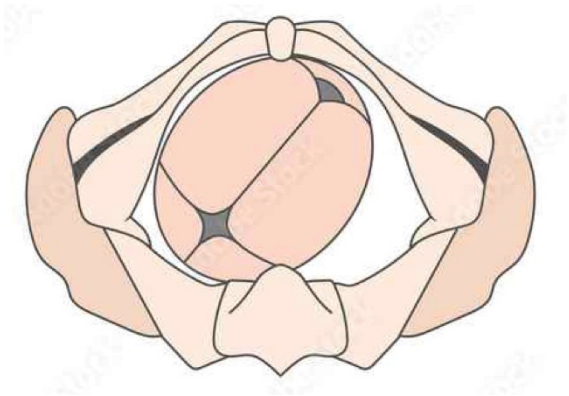


- 1 주 뒤 생물리학계수 측정

- 1 주 뒤 재검사
- 제왕절개
- 유도분만
- 경과관찰

[정상진통 및 분만]

38. (22 계통) 다음에 해당하는 Fetal orientation 은?



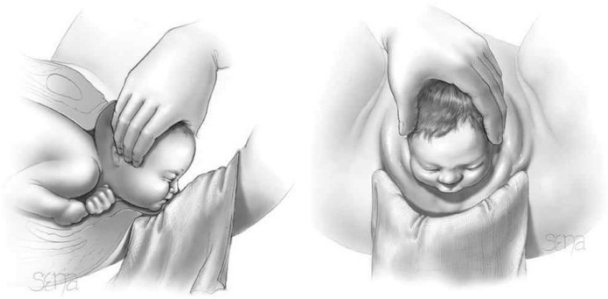
- ROA
- LOA
- ROP
- LOP
- OA

39. (22 계통) 후두위의 질식분만 중 Cardinal movement 중에서 fetal occiput 이 symphysis pubis 를 향하여 앞쪽으로 회전하여 O-A position 을 유도하는 과정은?



- External rotation
- Internal rotation
- Expulsion
- Descent
- Engagement

40. (22 계통변형) 리트겐 수기가 돕는 다음 과정은?



- Extension
- Expulsion
- Internal rotation
- External rotation
- Engagement

41. (21 학년말) 앙와위에서 자궁의 윤곽을 파악. 자궁 저부 촉진하고 자궁 옆면을 촉진하고 태아의 팔다리 방향을 확인하는 것으로 태축, 태위, 태향 등을 알 수 있음. 양수과다증이 이있거나 산모가가 비만일 경우 판단하기기 어려움. 이 수기는?

- 맥로버트
- 리트겐
- 모리쉐
- 레오폴드
- 피나드

42. 두정위에서 양쪽마루뼈지름(biparietal diameter)이 골반입구를 통과하는 것을 이르는 말은?

- 진입

- 내회전
- 신전
- 굴곡
- 하강

[난산]

43. (21 계통변형)임신 40 주 다분만부 25 세 여성이 규칙적인 진통으로 내원하였다. 자궁경부개대는 1cm, 자궁경부의 숙화 정도는 30%, 태아의 아두하강도는 -1 이었다. 16 시간이 지난 후에도 자궁경부가 그대로일 때, 진단은?

- Protracted active-phase dilatation
- Arrest of descent
- Secondary arrest of dilatation
- Normal labor
- Prolonged latent phase

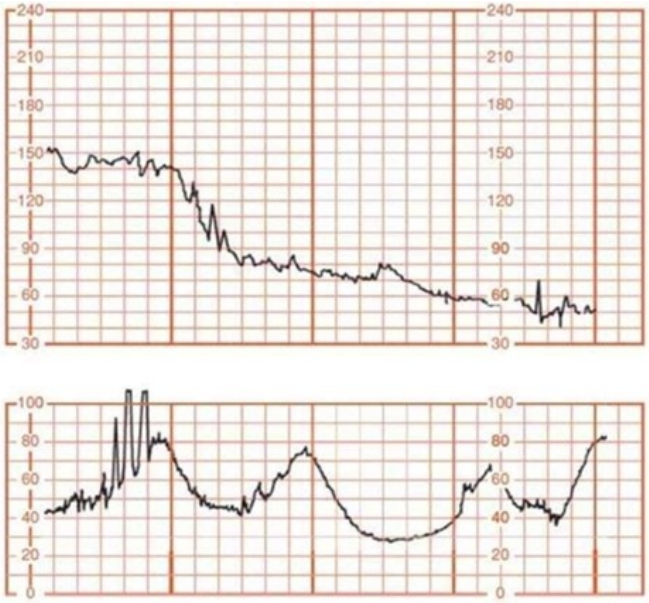
44. 진통 억제제 중 다음과 같은 특성을 가지는 것은?

칼슘길항작용 과량 시 호흡부전 태아 neuroprotective

- 리토드린
- 황산마그네슘
- Terbutaline

[임신 고혈압]

45. 임신성 고혈압이 있는 임신 36 주 산모가 복통을 주소로 내원하였다. 혈압은 180/120 이었고, NST 는 다음과 같다. 자궁목순화는 일어나지 않았다. 처치는?



- 제왕절개
- 경과관찰
- 옥시토신
- 양수주입
- 좌측 측와위로 변경

46. 34 세 임신 36 주인 산모가 심한 두통으로 내원하였다. 혈압 180/110mmHg, 단백뇨 4+, 부종 (2+, 2+), 자궁 경부 1cm 개대, 80% 소실되었고 BPP score 8 점이었다. 알맞은 처치는?

- 분만
- 경과관찰
- 글루코코르티코이드
- 황산마그네슘
- 푸로세미드

47. 임신 중 고혈압에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 저용량 아스피린을 추가하면 전자간증으로 진행을 예방할 수 있다.

- 160/110mmHg 일 때 ACE inhibitor 를 이용하여 130/110mmHg 로 낮출 수 있다.
- sFlt-1/PLGF 가 38 미만이면 전자간증의 위험이 적다고 예측할 수 있다.
- 산모의 혈압이 높은 경우 태반조기박리 위험이 3 배 증가한다.
- 혈관 내피의 파괴에 의해 platelet 과 fibrin 의 침착이 관찰된다.

[산과적 출혈]

48. 33 세 37 주 산모가 진통으로 내원하였는데, 세게 찌르는 듯한 통증을 느낀 이후 질출혈과 함께 태아 심음이 잘 들리지 않았다. 진찰상 임신낭은 만져지지 않았을 때, 진단은?
    - 잔류태반
    - 자궁내감염
    - 자궁파열
    - 산도열상
    - 자궁이완증

49. 34 세 산모가 4.1kg 아이를 성공적으로 질식분만하고 태반도 완전 만출되었으나 지속적인 질출혈이 있었다. 복부검사에서 배꼽 위가 물렁물렁하게 만져졌다. 다음 중 해야 하는 처치로 옳은 것은?
    - 베타메타손
    - 리토드린
    - 경과관찰
    - 긁어냄술
    - 옥시토신

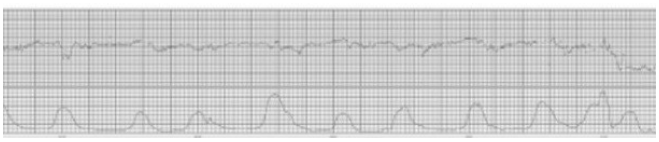
50. 임신 35 주, 28 세 초산부가 무통성의 다량의 질출혈과 어지럼증으로 내원하였다. 이전에는 이런 적이 없었다고 하였다. 헤모글로빈 수치는 9%이었으며, 혈압은 80/50mmHg 이었다. FHR 140/min, 적절한 처치는?
    - 제왕절개
    - 경과관찰
    - 옥시토신
    - 양수천자
    - 유도분만

[임신의 내과적 외과적 합병증]

51. 임신 25 주인 34 세 미분만부가 산전 진찰을 위해 병원에 왔다. 검사 결과는 다음과 같았다. 혈액 50g OGTT 155mg/dL. 처치는?
    - 1 주 후 50g OGTT 재검
    - Insulin
    - 식이요법
    - 100g OGTT
    - 경과관찰

[지연임신]

52. 다음과 같은 NST 가 관찰되는 과숙아 병태생리와 관련된 원인은? (답 논란)



    - 양수과소증
    - 과숙증후군
    - 태반부전

- 거대아

*두부압박 보기 없었음

Prolonged deceleration : 지속되는 탯줄의 압박, 태아의 두부압박, 심각한 정도의 태반 기능 부전 등이 야기할 수 있음.

* 최대한 비슷한 사진으로 구글에서 가져왔습니다. Early deceleration 과 비슷하였으나 variable deceleration 인 것으로 해석해 양수과소증이 답이라는 의견도 있었습니다.

[태아 성장 지연]

53. 35 주 산모, 산전 진찰 받으러 병원 내원, FGR(5 백분위수), AFI 4, reverse end-diastolic flow(도플러 사진으로 제시함) 일 때 처치는?

- 경과관찰
- 프로게스테론
- 리토드린
- 양수주입술
- 분만

[유산]

54. 10 주 산모, 질출혈로 내원. 자궁 경부 닫힌 상태. FHR 140. 처치는?

- 침상 안정
- 자궁긁어냄술
- 저용량 아스피린

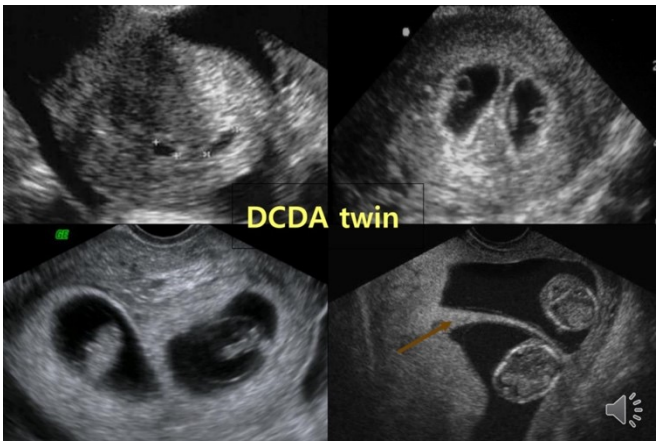
*절박유산은 효과적인 치료방법이 없고 경과관찰하는 것이 처치. 필요하다면 아세트아미노펜으로 통증 치료

55. 6 주 산모, 질출혈로 내원. 자궁목 2cm 개대, 초음파 상에서 ?주전 보였던 임신낭이 보이지 않고 혼합 에코성 물질이 보임. 처치는?

- 자궁내막긁어냄술

[다태 임신]

56. 10 주 산모. USG 사진 보여줌



- MCDA
- MCMA
- DCMA
- DCDA

*강의록 사진 가져왔고, 실제 시험에서는 4 번째 사진과 유사하게 lambda sign 에 화살표가 표시되어 있었음

[다태임신]

57. 25 주 산모, 쌍둥이 산전진찰 위해 병원 내원. 처치는?

	예측태아몸무게	최대양수주머니 수직깊이	탯줄동맥도플러초음파	정맥관도플러초음파
여	10백분위수	2cm	정상	정상
남	70백분위수	7cm	정상	정상

- 추적관찰
- 양수감압술

- 양수주입술
- 사이막절개술
- 혈관문합 태아경 레이저절제술

[유산]

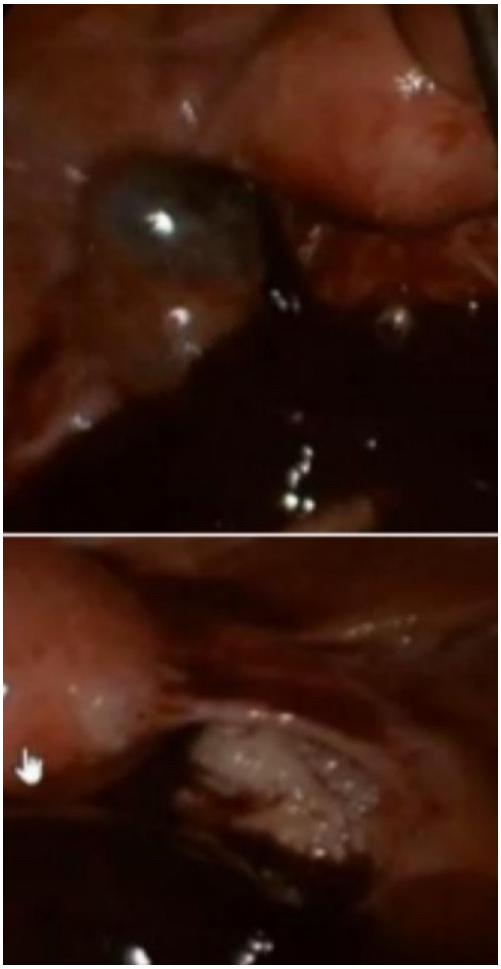
58. 임신 22 주 (24 주 이내였음) 산모. 초음파 사진 제시. 처치는?



- 경과관찰
- 자궁목원형결찰술

[자궁외임신]

59. 산과력 2-0-2-2 인 36 세 여성환자가 6 주째 무월경 및 복통을 주소로 내원. 요임신검사 양성. 하복부 심한 통증과 압통 있었음. 더글라스 천자 했더니 50mL 의 응고되지 않은 출혈 발견하여 응급수술함. 수술의 이름은?



- 좌측 난관 절제술
- 좌측 난소난관절제술
- 우측 난관 절제술
- 우측 난소난관절제술
- 자궁절제술

* 오른쪽 자궁부속기 정상, 왼쪽 자궁부속기 부푼 사진 주어짐.

[기타]

60. (21 학년말)환자가 치료받고자 하는 문제에 대해 시간 순으로 명시한 것. 어디가 아프고, onset, duration, 등등 언제 악화되고 언제 완화되는지 등등 알아보는 것과 관련된사항은?

- Present illness
- Chief complaint
- Initial assessment

- Physical examination
- Review of system